Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής
Ογκολογίας (Ε.Ε.Π.Ο.)

Σε συνεργασία με την:
Ουρολογική Κλινική
ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

©2018 E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού
LUTS

29 | 30
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Styga Mountain Hotel
Ζαρούχλα Αχαΐας

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Υψηλή τεχνολογία
για μια νέα προοπτική στη
φροντίδα της ακράτειας

Spirit™

Ανδρικός εξωτερικός
καθετήρας σιλικόνης
με υδροκολλοειδές
κολλητικό

BARD | CARE
Care. Comfort. Choice.

gcp med
ΓενικηΧημικων

Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε., Αυγής 60, Κηφισιά
Τηλ: 210 6203000, Γραμμή χωρίς χρέωση : 800 500 5150
info@gcp.gr / www.gcp.gr

BENEFITS STICK. TISSUE DOESN'T.

Nonstick nano-coating makes these new LigaSure™ devices better than ever

It's more than just a coating on the jaws. It's:

- Less sticking[1–3,†]
- Less eschar buildup[4–6,‡]
- Fewer cleanings[4–6,§]

It's more efficient patient care.

LigaSure™ blunt tip device

LigaSure™ Maryland jaw device

LigaSure Impact™ device

Note: Standard reprocessing methods will degrade the nonstick coating and lead to an increase in sticking, eschar buildup, and cleanings.[7–9]

---

†Instances of tissue sticking to jaws measured over 110 seals per device. ‡Eschar buildup assessed using optical imaging analysis after 20, 40, and 60 seal and divide cycles. §Cleaning effectiveness assessed after each of two cleaning cycles. 1. Based on internal test report #RE00062678, Benchtop tissue sticking comparison of the Enseal™* G2, Voyant™* 5 mm Fusion, LigaSure™ LF1637, and LigaSure™ LF1837 devices conducted on porcine uterine tissue using the ForceTriad™ energy platform. Instances of tissue sticking to jaws measured over 110 seals per device. Oct. 5, 2016. 2. Based on internal test report #RE00034755, LF4418 design verification report: benchtop testing using porcine abdominal aorta, mesentery, and renal arteries, with average (lb) sticking force. Feb. 24, 2016 and March 25, 2016. 3. Based on internal test report #RE00073194, Tissue sticking comparison of the Ethicon G2™* , Voyant™* 5 mm Fusion, LigaSure™ LF1737, and LigaSure™ LF1937 devices conducted on porcine tissue using the Force Triad™ energy platform. Jan. 18, 2017. 4. Based on internal test report #RE00063136, Lig-42 report product claim LF1823, LF1837, and LF1844: benchtop testing conducted using porcine uterine tissue, a wet gauze cleaning fixture, and optical imaging analysis. Sept. 9, 2016. 5. Based on internal test report #RE00057355, Lig-40 report product claim LF4418: benchtop testing using porcine uterine tissue. July 29, 2016. 6. Based on internal test report #RE00071599, MJC marketing claims testing for the LF19XX, conducted on porcine tissue. Feb. 7 to Feb. 22, 2017. 7. Based on internal test report #RE00065374 Rev A, LF18XX product claims report for reprocessed jaws; Sept. 22 and Sept. 29, 2016. 8. Based on internal test report #RE00065124, Lig-40 LF4418 product claims report for reprocessed jaws: benchtop testing conducted with reprocessed device jaws using porcine tissue, porcine blood, and average (lb) tissue sticking force. Oct. 4-7, 2016. 9. Based on internal report #RE00045785, LF19XX Waiver of Sticking Testing Post-reprocessing. Jan. 19, 2017.

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Medtronic Ελλάδος
Γκιώνας 1Α, Μεταμόρφωση, 57001, Αθήνα, Τ: 210 20 20 232

Medtronic
Further, Together

© 2018 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. 05/2018

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS) αναφέρονται σε μία ομάδα συμπτωμάτων που αφορούν όχι μόνον όλα τα όργανα του κατώτερου ουροποιητικού αλλά και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου.

Παραδοσιακά διακρίνονται σε τύπου αποθήκευσης (συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ούρηση – ακράτεια ούρων, επώδυνη ούρηση, ενούρηση) και τύπου κένωσης της ουροδόχου κύστεως (χαμηλή ροή ούρων, δυσκολία έναρξης ούρησης, τελική στάγδην ούρηση, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστεως, οξεία και χρόνια επίσχεση ούρων).

Αν και τα LUTS είναι στο μυαλό των περισσοτέρων συνυφασμένα με ηλικιωμένους άνδρες δεν είναι ασυνήθιστη η ύπαρξή τους σε νέους αλλά και γυναίκες. Επίσης πρέπει να καταστεί σαφές ότι η καλοήθης υπερπλασία προστάτου, αν και η συχνότερη αιτία, δεν είναι το μόνο παθογενετικό αίτιο. Πολλές παθήσεις (νευρολογικές, παθολογικές κλπ) και όχι μόνον ουρολογικές, εμφανίζονται με LUTS.

Το διήμερο 29-30/06/2018 στην ορεινή Αχαΐα σ΄ ένα καταπράσινο, δροσερό, δασικό περιβάλλον, επιστήμονες γνωστού κύρους και εμπειρίας θα προσπαθήσουν μέσα από ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο να ξεδιαλύνουν όλες τις πτυχές διάγνωσης, διερεύνησης και θεραπείας αιτιών που προκαλούν LUTS.

Με τιμή

Κωνσταντίνος Ντούμας
Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
ΓΝΑ ΄΄Γ. Γεννηματάς΄΄

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ντούμας Κωνσταντίνος
Μέλη: Αρίστας Οδυσσέας
Γκιάλας Ιωάννης
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σταθούρος Γεώργιος
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ντούμας Κωνσταντίνος
Μέλη: Αβακιάν Ράφφη
Αθανασόπουλος Αναστάσιος
Βαρκαράκης Ιωάννης
Γαλανάκης Ιωάννης
Γαλάτα Αγγελική
Γιαννίτσας Κωνσταντίνος
Γλύκας Ιωάννης
Διαμαντίδης Ευγένιος
Ζαχαράκης Ευάγγελος
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος
Μακαρόυνας Κωνσταντίνος
Μανούσακας Θεόδωρος
Μητσογιάννης Ηρακλής
Μπαφαλούκας Νικόλαος
Μπούγας Δημήτριος
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Παπαδημητρίου Βάϊος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Πετρολέκας Ανδρέας
Σπυρόπουλος Ευάγγελος
Σταθούρος Γεώργιος
Τσιμάρης Ιωάννης
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Αριστόδημος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **29** ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

11:30-12:00	**Εγγραφές**	
12:00-15:30	**Αναζητώντας τα Guidelines** Προεδρείο: **Κ. Ντούμας**	
12:00-12:30	LUTS μη νευρογενούς αιτιολογίας.	**Γ. Σταθούρος**
12:30-13:00	Νευρουρολογία.	**Γ. Παπαδόπουλος**
13:00-13:30	Ουρολοιμώξεις.	**Χ. Φραγκούλης**
13:30-14:00	Ακράτεια ούρων.	**Ι. Γλύκας**
14:00-14:30	Χρόνιο πυελικό άλγος.	**Ρ. Αβακιάν**
14:30-15:30	Συζήτηση περιστατικών.	**Χ. Κωνσταντινίδης Θ. Μανούσακας**
15:30-16:00	**Διάλειμμα-Καφές**	
16:00-18:00	**Video και σχολιασμός ενδοσκοπικών προστατεκτομών** Προεδρείο: **Κ. Ντούμας**	
17:00-17:30	Μονοπολική προστατεκτομή.	
17:30-18:00	Διπολική προστατεκτομή.	
18:00-18:30	Laser εξάχνωση.	
	Σχολιαστής	**Γ. Σταθούρος**
18:00-18:30	**Διάλειμμα-Καφές**	
18:30-20:00	**Νοσηλευτική Φροντίδα ασθενών με LUTS.** Προεδρείο: **Κ. Ντούμας, Χ. Κωνσταντινίδης**	
18:30-19:00	Διαχείριση και απολύμανση ενδοσκοπικών εργαλείων.	**Ε. Σκαρμούτσου**
19:00-19:30	Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην οργάνωση και λειτουργία του Ουροδυναμικού ιατρείου.	**Α. Νικολιά**
19:30-20:00	Εκπαίδευση/συμμόρφωση ασθενών που κάνουν αυτοκαθετηριασμούς	**Ε. Διαμαντίδης**
20:00-21:00	**Διάμεση κυστίτιδα και χρόνιο πυελικό άλγος** Προεδρείο: **Α. Φραγκούλης**	
20:00-20:30	Διάμεση κυστίτιδα	**Θ. Μανούσακας**
20:30-21:00	Χρόνιο πυελικό άλγος	**Π. Νικολόπουλος**

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09:00-11:00	**Γενικά στοιχεία/Φαρμακευτική θεραπεία** Προεδρείο: **Δ. Μπούγας, Π. Νικολόπουλος**	
09:00-09:30	Αιτιολογία/Ορισμοί/Εργαλεία Διερεύνησης LUTS	**Κ. Γιαννίτσας**
09:30-10:00	A-blockers, 5ARIs, Παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της φαρμακευτικής θεραπεία;	**Χ. Φραγκούλης**
10:00-10:30	Ποιος ο ρόλος της Φυτοθεραπείας;	**Ι. Γλύκας**
10:30-11:00	Είναι τα αντιχολινεργικά η νέα πρόταση; Δρουν καλύτερα μετά την προστατεκτομή;	**Ρ. Αβακιάν**
11:00-11:30	**Διάλειμμα-Καφές**	
11:30-13:30	**Χειρουργική αντιμετώπιση της BPH** Προεδρείο: **Κ. Ντούμας, Θ. Μανούσακας**	
11:30-12:00	Μονοπολική & διπολική διουρηθρική προστατεκτομή.	**Γ. Σταθούρος**
12:00-12:30	Laser προστατεκτομή/εξάχνωση. Η νέα πρόταση στα μεγάλα αδενώματα;	**Ν. Μπαφαλούκας**
12:30-13:00	Υπολειτουργικός εξωστήρας: Πότε χειρουργούμε το αδένωμα;	**Γ. Παπαδόπουλος**
13:00-13:30	Στενώματα ουρήθρας: Διαστολές, ουρηθροτομή ή ουρηθροπλαστική;	**Ε. Ζαχαράκης**
13:30-16:30	**Μεσημβρινή διακοπή – Γεύμα**	
16:30-18:30	**Υπερλειτουργική και Νευρογενής κύστη.** Προεδρείο: **Α. Αθανασόπουλος, Ι. Βαρκαράκης**	
16:30-17:00	Υπερλειτουργική κύστη στους άνδρες: Θεραπεύεται μετά την προστατεκτομή;	**Ι. Τσίμαρης**
17:00-17:30	Συνήθεις Νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν LUTS. Κατανοώντας τη Νευρογενή κύστη.	**Χ. Κωνσταντινίδης**
17:30-18:00	Μη ειδικές και ειδικές λοιμώξεις ως αιτία LUTS & υπερδραστήριας κύστης.	**Ι. Γαλανάκης**
18:00-18:30	Ασκήσεις πυελικού εδάφους στους ασθενείς με LUTS/ακράτεια.	**Α. Γαλάτα**
18:30-19:00	**Διάλειμμα-Καφές**	
19:00-21:00	**Παθολογικές οντότητες που σχετίζονται ή συνυπάρχουν με τα LUTS.** Προεδρείο: **Ε. Σπυρόπουλος, Η. Μητσογιάννης**	
19:00-19:30	Γήρανση & LUTS.	**Α. Πετρολέκας**
19:30-20:00	Σακχαρώδης διαβήτης και LUTS.	**Η. Μητσογιάννης**
20:00-20:30	Κατανοώντας τη νυκτουρία: Μηχανισμοί & λύσεις.	**Β. Παπαδημητρίου**
20:30-21:00	LUTS & Στυτική δυσλειτουργία: Υπάρχουν κοινά μονοπάτια; Ο ρόλος των PDE5I.	**Κ. Μακαρούνης**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αβακιάν Ράφφη	Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο
Αθανασόπουλος Αναστάσιος	MD, PhD, Καθηγητής Νευροουρολογίας & Ουροδυναμικής Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών
Βαρκαράκης Ιωάννης	PhD FEBU ECFMG, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
Γαλανάκης Ιωάννης	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Γαλάτα Αγγελική	MD, PhD, SFEBPRM, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Γιαννίτσας Κωνσταντίνος	Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Γλύκας Ιωάννης	Ειδικευόμενος Ουρολόγος, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
Διαμαντίδης Ευγένιος	Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Φ.Ι.Απ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
Ζαχαράκης Εμμανουήλ	PhD, FRCS(Eng), FECSM, FEAA, Χειρουργός Ουρόλογος
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος	MD, FEBU, FECSM, Ουρολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Μακαρούνης Κωνσταντίνος	MD, FEBU, FECSM, cPhD, Ουρολόγος Ανδρολόγος
Μανούσακας Θεόδωρος	FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Γ' Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"
Μητσογιάννης Ηρακλής	MD, PhD, FEBU, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Β' Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
Μπαφαλούκας Νικόλαος	FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Fellow of Endourological Society
Μπούγας Δημήτριος	Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Λαϊκό» Νοσοκομείο
Νικολιά Αρχοντία	MSc , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων ΕΚΑ
Νικολόπουλος Παναγιώτης	MD, phD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, 417 ΝΙΜΤΣ
Ντούμας Κωνσταντίνος	Ουρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
Παπαδημητρίου Βάιος	Χειρουργός Ουρολόγος, Ιδιωτικό ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο, Λαμία

Παπαδόπουλος Γεώργιος	Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
Πετρολέκας Ανδρέας	Επιμελητής, Β’ Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”
Σκαρμούτσου Ελένη	Νοσηλεύτρια, MSc, Χειρουργείο Γ.Κρ.Ν.Α, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
Σπυρόπουλος Ευάγγελος	Χειρουργός Ουρολόγος, Αρχιπλοίαρχος Ιατρός ΠΝ ε.α, τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan & Βιοκλινική Πειραιά
Σταθούρος Γεώργιος	FEBU, Ουρολόγος, Επιμελητής Β’, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
Τσίμαρης Ιωάννης	Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Φραγκούλης Χαράλαμπος	Ουρολόγος, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

ΧΟΡΗΓΟΙ

Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή της Διημερίδας ευχαριστεί τις ακόλουθες εταιρείες, κατά αλφαβητική σειρά, που συνέβαλαν σημαντικά στην πραγματοποίησή του.

ariti®

astellas

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FERRING
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

innovis
Future health today

inside
MEDICAL

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

MAVROGENIS
Coloplast Medtronic

Meditrina
pharmaceuticals

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

RECORDATI HELLAS
GROUP

sti lvi
για την υγεία

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

Vocate
Φαρμακευτική α.ε.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

gcp med
ΓενικηΧημικων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Π.Ο.)

Σε συνεργασία
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. Γεννηματάς

Ημερομηνία Διεξαγωγής
29-30 Ιουνίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Styga Mountain
Ζαρούχλα Αχαΐας, Ορεινή Αχαΐα
Τηλ: 26960 31431

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Σε όλους τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Τα πιστοποιητικά θα δοθούν το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018.

Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώσουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Γραμματεία Διημερίδας

ets Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr ets@events.gr
Website: www.events.gr

Σημειώσεις

Σημειώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MINIRIN® Melt 60 μg δισκίο λυοφιλοποιημένο από του στόματος
MINIRIN® Melt 120 μg δισκίο λυοφιλοποιημένο από του στόματος

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε λυοφιλοποιημένο από του στόματος δισκίο MINIRIN® Melt 60 μg περιέχει 60 μg δεσμοπρεσσίνης (ελεύθερης βάσης), που έχει προστεθεί ως οξική δεσμοπρεσσίνη. Κάθε λυοφιλοποιημένο από του στόματος δισκίο MINIRIN® Melt 120 μg περιέχει 120 μg δεσμοπρεσσίνης (ελεύθερης βάσης), που έχει προστεθεί ως οξική δεσμοπρεσσίνη. **Αντενδείξεις**. Το MINIRIN® Melt αντενδείκνυται σε περιπτώσεις: • Υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. • Τακτικής ή ψυχογενούς πολυδιψίας (που έχει ως αποτέλεσμα παραγωγή ούρων που υπερβαίνει τα 40 ml/kg/24ωρο) και πολυδιψίας εξαιτίας καταχρήσεως οινοπνεύματος (ποτομανίας). • Ιστορικού γνωστής ή πιθανής καρδιακής ανεπάρκειας και άλλων παθήσεων που απαιτούν θεραπεία με διουρητικά. • Μέτριας και σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 50 ml/min). • Υπονατριαιμίας ή προδιάθεσης για υπονατριαιμία. • Περιπτώσεων που δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί η λήψη υγρών. • Νόσου Von Willebrand Τύπου IIb. • Συνδρόμου απρόσφορης εκκρίσεως αντιδιουρητικής ορμόνης επειδή το σύνδρομο αυτό σχετίζεται με την υπονατριαιμία εξ'αραιώσεως. • Σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών για την αγωγή της πρωτοπαθούς νυκτερινής ενούρησης. • Σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών για τη συμπτωματική θεραπεία της νυκτουρίας. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση**. *Ειδικές προειδοποιήσεις*. Όταν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της Πρωτοπαθούς Νυκτερινής Ενούρησης και της Νυκτουρίας, η πρόσληψη υγρών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και μόνο για να ικανοποιήσει το αίσθημα της δίψας, από 1 ώρα προ και 8 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Η θεραπεία χωρίς ταυτόχρονη ελάττωση της πρόσληψης υγρών μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση ύδατος και/ή υπονατριαιμία με ή χωρίς συνοδά προειδοποιητικά σημεία και συμπτώματα (κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, αύξηση βάρους και σε σπάνιες περιπτώσεις σπασμοί). Σε όλους τους ασθενείς και, όπου εφαρμόζεται, στα άτομα που τους φροντίζουν πρέπει να δίδεται με ιδιαίτερη προσοχή η συμβουλή να εφαρμόζουν τον περιορισμό πρόσληψης υγρών. *Προφυλάξεις*. Πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την αποφυγή υπερφόρτισης με υγρά. • Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος 'δηλητηριάσεως με νερό', μέσω υπονατριαιμίας, η δοσολογία πρέπει να ρυθμίζεται με προσοχή, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. • Σε καταστάσεις και σε σοβαρές συνοδές παθήσεις που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ισορροπίας ύδατος και ηλεκτρολυτών (όπως συστηματικές λοιμώξεις, πυρετός, γαστρεντερίτιδα), η θεραπεία με δεσμοπρεσσίνη πρέπει να διακόπτεται. • Σε ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ενδοκρανιακής πίεσης πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις. • Πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η περίπτωση δυσλειτουργίας της κύστης και η απόφραξη των ουροφόρων πόρων πριν την έναρξη της θεραπείας. • Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε άτομα που πάσχουν από κυστική ίνωση. • Η δεσμοπρεσσίνη σε υψηλές δόσεις μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει ελαφρά αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία εξαφανίζεται με τη μείωση της δοσολογίας. Σε ασθενείς με στεφανιαία ανεπάρκεια και/ή αρτηριακή υπέρταση, η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται ή να μειώνεται, εάν είναι αναγκαίο, παρά το γεγονός ότι η δεσμοπρεσσίνη έχει απλώς ελαφρά αγγειοσυσπαστική δράση. • Σε περίπτωση ανεπάρκειας παραγωγής κορτιζόλης, αυτή πρέπει να διορθώνεται προ της έναρξης της θεραπείας και κατά τη διάρκειά της ώστε να προληφθεί ο όποιος κίνδυνος υπονατριαιμίας. • Οι ηλικιωμένοι ασθενείς και οι ασθενείς με επίπεδα νατρίου σε τιμές στο χαμηλότερο όριο των φυσιολογικών τιμών μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπονατριαιμίας. Σε περίπτωση συγχορήγησης με φάρμακα που είναι γνωστό ότι επάγουν το σύνδρομο της απρόσφορης εκκρίσεως της αντιδιουρητικής ορμόνης (π.χ. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, χλωροπρομαζίνη και καρβαμαζεπίνη, συγχορήγηση με ΜΣΑΦ), πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις προκειμένου να αποφευχθεί η υπονατριαιμία, περιλαμβανομένων της προσεκτικής μείωσης της κατανάλωσης υγρών και του συχνότερου ελέγχου του νατρίου του ορού. **Ανεπιθύμητες ενέργειες.** ***Περίληψη του προφίλ ασφαλείας.*** Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια με τη δεσμοπρεσσίνη είναι η υπονατριαιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο, αύξηση σωματικού βάρους, ζάλη, σύγχυση, αίσθημα κακουχίας, δυσλειτουργία της μνήμης, ίλιγγο, πτώσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις σπασμούς και κώμα. Η πλειονότητα των ενηλίκων που λαμβάνουν θεραπεία για τη νυκτουρία και οι οποίοι αναπτύσσουν υπονατριαιμία είχαν εμφανίσει χαμηλά επίπεδα νατρίου στον ορό τρεις ημέρες μετά τη λήψη δόσης. Στους ενήλικες ο κίνδυνος για υπονατριαιμία αυξάνει με την αυξανόμενη δόση δεσμοπρεσσίνης και έχει βρεθεί ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες. Στους ενήλικες η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν η κεφαλαλγία (12%). Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η υπονατριαιμία (6%), ζάλη (3%), υπέρταση (2%) και γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία (4%), έμετος (1%), κοιλιακό άλγος (3%), διάρροια (2%) και δυσκοιλιότητα (1%). Λιγότερο συχνές είναι μία επίδραση στο ρυθμό του ύπνου/επίπεδα συνείδησης που παρουσιάζονται ως π.χ. αϋπνία (0,96%), υπνηλία (0,4%) ή εξασθένιση (0,06%). Δεν έχουν αναφερθεί αναφυλακτικές αντιδράσεις σε κλινικές μελέτες, ωστόσο υπήρξαν σε αυθόρμητες αναφορές. Στα παιδιά η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν η κεφαλαλγία (1%), λιγότερο συχνές ήταν οι ψυχιατρικές διαταραχές (συναισθηματική αστάθεια (0,1%), επιθετικότητα (0,1%), άγχος (0,05%), διακυμάνσεις της συναισθηματικής διάθεσης (0,05%), εφιάλτες (0,05%)), οι οποίες γενικά μετριάζονται μετά τη διακοπή της θεραπείας και γαστρεντερικές διαταραχές (κοιλιακό άλγος (0,65%), ναυτία (0,35%), έμετος (0,2%) και διάρροια (0,15%). Δεν έχουν αναφερθεί αναφυλακτικές αντιδράσεις σε κλινικές μελέτες, ωστόσο υπήρξαν σε αυθόρμητες αναφορές. ***Συνοπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών.*** *Ενήλικες:* Με βάση τη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε ενήλικες για τη θεραπεία της Νυκτουρίας με από του στόματος χορηγούμενη δεσμοπρεσσίνη (N=1557) και σε συνδυασμό με την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου από όλες τις ενδείξεις για ενήλικες (συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Άποιου Διαβήτη). Αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί μόνο μετά την κυκλοφορία έχουν προστεθεί στη στήλη – συχνότητα «Μη γνωστές».

Κατηγορία/ Οργανικό σύστημα	**Πολύ συχνές (> 1/10%)**	**Συχνές (1-10%)**	**Όχι συχνές (0,1-1%)**	**Σπάνιες (0,1-0,01%)**	**Μη γνωστές**
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	-	-	-	-	Αναφυλακτικές αντιδράσεις
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	-	Υπονατριαιμία*	-	-	Αφυδάτωση**, Υπερνατριαιμία**
Ψυχιατρικές διαταραχές	-	-	Αϋπνία	Συγχυτική κατάσταση*	-
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Κεφαλαλγία*	Ζάλη*	Υπνηλία, Παραισθησία	-	Σπασμοί*, Εξασθένιση**, Κώμα*
Οφθαλμικές διαταραχές	-	-	Οπτική διαταραχή	-	-
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου	-	-	Ίλιγγος*	-	-
Καρδιακές διαταραχές	-	-	Αίσθημα παλμών	-	-
Αγγειακές διαταραχές	-	Υπέρταση	Ορθοστατική υπόταση	-	-
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου	-	-	Δύσπνοια	-	-
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	-	Ναυτία*, Κοιλιακό άλγος*, Διάρροια, Δυσκοιλιότητα, Έμετος*	Δυσπεψία, Μετεωρισμός, Τυμπανισμός και διάταση της κοιλίας	-	-
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	-	-	Εφίδρωση, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση	Αλλεργική δερματίτιδα	-
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	-	-	Μυϊκοί σπασμοί, Μυαλγία	-	-
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών	-	Συμπτώματα της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας	-	-	-
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	-	Οίδημα, Κόπωση	Αίσθημα κακουχίας*, Θωρακικό άλγος, Γριππώδης συνδρομή	-	-
Παρακλινικές εξετάσεις	-	-	Σωματικό βάρος αυξημένο*, Ηπατικά ένζυμα αυξημένα, Υποκαλιαιμία	-	-

*Η υπονατριαιμία μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο, αύξηση σωματικού βάρους, ζάλη, σύγχυση, αίσθημα κακουχίας, επηρεασμένη μνήμη, ίλιγγο, πτώσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις σπασμούς και κώμα

**Παρατηρήθηκε μόνο στην ένδειξη του Κεντρικού Άποιου Διαβήτη

Παιδιά και έφηβοι: Με βάση τη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε παιδιά και εφήβους για τη θεραπεία της Πρωτοπαθούς Νυκτερινής Ενούρησης με από του στόματος χορηγούμενη δεσμοπρεσσίνη (N=1923). Αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί μόνο μετά την κυκλοφορία έχουν προστεθεί στη στήλη – συχνότητα «Μη γνωστές».

Κατηγορία/Οργανικό σύστημα	**Πολύ συχνές (> 1/10%)**	**Συχνές (1-10%)**	**Όχι συχνές (0,1-1%)**	**Σπάνιες (0,1-0,01%)**	**Μη γνωστές**
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	-	-	-	-	Αναφυλακτικές αντιδράσεις
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	-	-	-	-	Υπονατριαιμία*
Ψυχιατρικές διαταραχές	-	-	Συναισθηματική αστάθεια** Επιθετικότητα***	Συμπτώματα άγχους, Εφιάλτες*, Διακυμάνσεις της συναισθηματικής διάθεσης****	Μη φυσιολογική συμπεριφορά, Συναισθηματική διαταραχή, Κατάθλιψη, Ψευδαισθήσεις, Αϋπνία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	-	Κεφαλαλγία*	-	Υπνηλία	Διαταραχή στην προσοχή, Ψυχοκινητική υπερδραστηριότητα
Αγγειακές διαταραχές	-	-	-	Υπέρταση	-
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου	-	-	-	-	Επίσταξη
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	-	-	Κοιλιακό άλγος*, Ναυτία*, Έμετος*, Διάρροια,	-	-
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	-	-	-		Αλλεργική δερματίτιδα, Εξάνθημα, Εφίδρωση, Κνίδωση
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών	-	-	Συμπτώματα της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας	-	-
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	-		Περιφερικό οίδημα, Κόπωση	Ευερεθιστότητα	-

*Η υπονατριαιμία μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο, αύξηση σωματικού βάρους, ζάλη, σύγχυση, αίσθημα κακουχίας, επηρεασμένη μνήμη, ίλιγγο, πτώσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις σπασμούς και κώμα

**Ίσος αριθμός αναφορών μετά την κυκλοφορία σε παιδιά και εφήβους (<18 ετών)

***Μετά την κυκλοφορία αναφέρθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους (<18 ετών)

****Οι αναφορές μετά την κυκλοφορία αφορούν κυρίως σε παιδιά (<12 ετών)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια με τη δεσμοπρεσσίνη είναι η υπονατριαιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο, αύξηση σωματικού βάρους, ζάλη, σύγχυση, αίσθημα κακουχίας, επηρεασμένη μνήμη, ίλιγγο, πτώσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις σπασμούς και κώμα. Η αιτία της πιθανής υπονατριαιμίας είναι η προβλεπόμενη αντιδιουρητική δράση. Η υπονατριαιμία είναι αναστρέψιμη και σε παιδιά συχνά φαίνεται να παρουσιάζεται σε σχέση με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την πρόσληψη υγρών και/ή την εφίδρωση. Σε μελέτη ενήλικων ατόμων που έλαβαν θεραπεία για τη νυκτουρία, η πλειοψηφία αυτών που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα νατρίου στον ορό, το εμφανίζουν αυτό κατά τις πρώτες μέρες της θεραπείας ή σε σχέση με αύξηση της δόσης. Και στους ενήλικες και στα παιδιά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις προφυλάξεις που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο. ***Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί:*** Ηλικιωμένοι ασθενείς και ασθενείς με επίπεδα νατρίου στον ορό στα χαμηλότερα φυσιολογικά όρια μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν υπονατριαιμία. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 213 2040380/337,
Φαξ: + 30 210 6549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ, Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Minirin®
ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΣΚΙΑ ΔΕΣΜΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣ
MELT 60/120 μg

Η αιτιολογική θεραπεία
της Νυκτουρίας

FERRING
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ
Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210 6843449, fax: 210 6844721
www.ferring.gr

Nictur®
Δεσμοπρεσσίνη 360mcg/ml
Πόσιμο διάλυμα
Η ευέλικτη δοσολογία
κάνει τη διαφορά
Meditrina
pharmaceuticals
Αθήνα: Ηρακλείτου 117, 152 38 Χαλάνδρι. Τηλ: 210 67 26 260
Θεσσαλονίκη: Λαέρτου 22, 55535 Πυλαία, Capital Trade Center. Τηλ: 2310 478 891
www.meditrina.gr - info@meditrina.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml πόσιμο διάλυμα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 360 μικρογραμμάρια ανύδρης και ελεύθερης οξικών δεσμοπρεσσίνης, ισοδύναμα με 400 μικρογραμμάρια οξικής δεσμοπρεσσίνης. Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Άλας νατρίου του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα (E 219): 2,1 mg/ml, Άλας νατρίου του p-υδροξυβενζοϊκού προπυλεστέρα (E 217): 0,22 mg/ml

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πόσιμο διάλυμα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το πόσιμο διάλυμα Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml ενδείκνυται για τη θεραπεία του κεντρικού άποιου διαβήτη και τη θεραπεία της πρωτοπαθούς νυχτερινής ενούρησης σε ασθενείς (ηλικίας άνω των 5 ετών) με φυσιολογική δυνατότητα συμπύκνωσης ούρων.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το πόσιμο διάλυμα Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml προορίζεται για από στόματος χρήση.

Θεραπεία του κεντρικού άποιου διαβήτη: Μια κατάλληλη αρχική δόση σε ενήλικες και παιδιά είναι 90 μικρογραμμάρια (0,25 ml) τρεις φορές ημερησίως. Η δοσολογία προσαρμόζεται εξατομικευμένα στον άποιο διαβήτη, αλλά η κλινική εμπειρία κατέδειξε ότι η συνολική ημερήσια δόση συνήθως βρίσκεται στην περιοχή από 180 μικρογραμμάρια (0,5 ml) έως 1080 μικρογραμμάρια (3 ml) δεσμοπρεσσίνης. Στη συνέχεια, αυτό το δοσολογικό σχήμα θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την ανταπόκριση του ασθενή. Στους περισσότερους ασθενείς, η δόση συντήρησης είναι 90 – 180 μικρογραμμάρια (0,25 – 0,5 ml) τρεις φορές ημερησίως. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα κατακράτησης υγρών ή/και υπονατριαιμίας (κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, αύξηση σωματικού βάρους και, στις σοβαρές περιπτώσεις, κρίσεις), η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και η δόση δεσμοπρεσσίνης να επαναπροσαρμοστεί.

Πρωτοπαθής νυχτερινή ενούρηση: Η κατάλληλη αρχική δόση είναι 180 μικρογραμμάρια (0,5 ml) δεσμοπρεσσίνης πριν τον ύπνο. Η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 360 μικρογραμμάρια (1 ml), εάν η χαμηλότερη δόση δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Το πόσιμο διάλυμα Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml συνιστάται για διάρκεια θεραπείας 3 μηνών. Σε συνέχεια με μακροχρόνια θεραπεία, θα πρέπει κάθε τρεις μήνες να παρεμβάλλεται μια περίοδος τουλάχιστον μίας εβδομάδας χωρίς θεραπεία, ώστε να αξιολογείται εάν έχει συμβεί αυτόματη θεραπεία. Θα πρέπει να ελέγχεται η πρόσληψη υγρών.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή σημεία κατακράτησης υγρών ή/και υπονατριαιμίας (κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, αύξηση σωματικού βάρους και, στις σοβαρές περιπτώσεις, κρίσεις), η θεραπεία πρέπει να διακοπεί, έως ότου ο ασθενής αναρρώσει. Αφού αποκατασταθεί η θεραπεία, η πρόσληψη υγρών πρέπει να ελέγχεται στενά (βλ. παράγραφο 4.4). Εάν μετά από 4 εβδομάδες τιτλοποίησης της δόσης δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί.

Η θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών (ηλικίας ≥ 65 ετών) πρέπει να παρακολουθείται στενά λόγω του αυξημένου κινδύνου υπονατριαιμίας. Τα επίπεδα συγκέντρωσης νατρίου στον ορό πρέπει να μετρώνται στην αρχή της θεραπείας, τρεις ημέρες μετά την εκκίνηση της θεραπείας ή σε τυχόν αύξηση της δόσης και τακτικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας.

4.3 Αντενδείξεις

- Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
- Ψυχογενής ή καθ' έξιν πολυδιψία.
- Γνωστό ή πιθανολογούμενο ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.
- Υπονατριαιμία ή προδιάθεση για υπονατριαιμία.
- Παθήσεις που απαιτούν ταυτόχρονη θεραπεία με διουρητικούς παράγοντες (βλ. παράγραφο 4.5).
- Μέτρια ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 50 ml/min).
- Μη ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση.
- Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, SIADH) – μια πάθηση που περιλαμβάνει απρόσφορα υψηλή έκκριση ADH.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ειδικές προειδοποιήσεις: Στην περίπτωση της πρωτοπαθούς νυχτερινής ενούρησης, η πρόσληψη υγρών πρέπει να περιορίζεται, ξεκινώντας 1 ώρα πριν τη χορήγηση και μέχρι το επόμενο πρωί (τουλάχιστον 8 ώρες). Η θεραπεία χωρίς ταυτόχρονη μείωση της πρόσληψης νερού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κατακράτηση υγρών ή/και υπονατριαιμία, με ή χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα και σημεία (κεφαλαλγία, ναυτία/έμετο, αύξηση του σωματικού βάρους και, σε σοβαρές περιπτώσεις, κρίσεις). Βλέπε παράγραφο 4.8. Συνεπώς, συνιστάται να εφιστάται σε αυτόν τον κίνδυνο η προσοχή των ασθενών, και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ασθενών και των γονέων μικρών παιδιών. Σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες που λάμβαναν δεσμοπρεσσίνη για τη νυχτερινή ενούρηση έχει αναφερθεί επανειλημμένα εγκεφαλικό οίδημα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με δεσμοπρεσσίνη, ενδέχεται να απαιτείται η παρακολούθηση του σωματικού βάρους, της συγκέντρωσης νατρίου στον ορό ή/και της αρτηριακής πίεσης. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία ή/και καρδιαγγειακή νόσο. Σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής νόσου, η αντιδιουρητική δράση του πόσιμου διαλύματος Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml θα ήταν μικρότερη από ότι συνήθως.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση: Προφυλάξεις για την αποτροπή υπονατριαιμίας, πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση:

- παθήσεων που χαρακτηρίζονται από διαταραχή του ισοζυγίου υγρών ή/και ηλεκτρολυτών, όπως συστημικές λοιμώξεις, πυρεξία, γαστρεντερίτιδα και SIADH (σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH).
- ταυτόχρονης θεραπείας με φάρμακα που είναι γνωστό ότι επάγουν το SIADH, όπως τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικούς αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης, χλωροπρομαζίνη και καρβαμαζεπίνη.
- ταυτόχρονη θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).
- Σε ασθενείς με κυστική ίνωση, η δεσμοπρεσσίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και η δόση πρέπει να προσαρμόζεται με βάση την ωσμωμοριακότητα του πλάσματος.
- Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο σοβαρής δυσλειτουργίας και απόφραξης της εξόδου της ουροδόχου κύστης πριν την εκκίνηση της θεραπείας.
- Σε ασθενείς με επιτακτική ακράτεια, οργανικές αιτίες αυξημένης συχνότητας ούρησης ή νυκτουρίας (π.χ. καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), λοίμωξη των ουροφόρων οδών, λιθίαση/όγκους της ουροδόχου κύστης, διαταραχές του σφιγκτήρα της ουροδόχου κύστης), πολυδιψία και μη επαρκώς ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να αντιμετωπίζεται ή να αποκλείεται πρωταρχικά η συγκεκριμένη αιτία των προβλημάτων.
- Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης νατρίου στον ορό ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπονατριαιμίας.

Προειδοποιήσεις για τα έκδοχα: Αυτό το προϊόν περιέχει άλας νατρίου του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα (E 219) και προπυλεστέρα (E 217). Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανόν όψιμες).

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό ότι επάγουν το SIADH, π.χ. τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, οι επιλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης, η χλωροπρομαζίνη και η καρβαμαζεπίνη ενδέχεται να προκαλέσουν προσθετική αντιδιουρητική δράση, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο κατακράτησης υγρών ή/και υπονατριαιμίας (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.4). Τα ΜΣΑΦ ενδέχεται να επάγουν κατακράτηση υγρών ή/και υπονατριαιμία (βλ. παράγραφο 4.4). Ταυτόχρονη θεραπεία με λοπεραμίδη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τριπλασιασμό των συγκεντρώσεων της δεσμοπρεσσίνης στο πλάσμα, που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο κατακράτησης νερού ή/και υπονατριαιμίας. Ταυτόχρονη θεραπεία με διουρητικούς παράγοντες αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3). Δεν είναι πιθανό η δεσμοπρεσσίνη να αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα που επηρεάζουν τον ηπατικό μεταβολισμό, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί σημαντικός μεταβολισμός σε in vitro μελέτες σε ανθρώπινα μικροσώματα. Ωστόσο, δεν έχουν διεξαχθεί επίσημες μελέτες in vivo. Ταυτόχρονη θεραπεία με διμεθικόνη ενδέχεται να μειώσει την απορρόφηση της δεσμοπρεσσίνης. Ένα τυποποιημένο γεύμα με 27% λιπαρά μείωσε την απορρόφηση της δεσμοπρεσσίνης (ρυθμός και έκταση). Δεν έχει παρατηρηθεί καμία σημαντική επίδραση στη φαρμακοδυναμική (παραγωγή και ωσμωμοριακότητα ούρων), ενώ υπάρχει δυναμικό να συμβεί αυτό σε χαμηλότερες δόσεις. Εάν σημειωθεί ελάττωση της δράσης, τότε πριν να αυξηθεί η δόση, πρέπει να εξεταστεί η επίδραση της τροφής.

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση: Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση δεσμοπρεσσίνης σε εγκύους. Μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς δράσεις αναφορικά με τοξικότητα για την αναπαραγωγή. Αναπαραγωγικές μελέτες που διεξήχθησαν σε επίμυες και κουνέλια σε δόσεις 100 φορές υψηλότερες από τη συνιστώμενη σε ανθρώπους δεν αποκάλυψαν ενδείξεις επιβλαβούς δράσης της δεσμοπρεσσίνης στο έμβρυο. Δεδομένα σε περιορισμένο αριθμό εκτεθειμένων κυήσεων σε γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε δεσμοπρεσσίνη κατά τη διάρκεια της κύησης δείχνουν σπάνιες περιπτώσεις διαμαρτιών σε παιδιά. Μολαταύτα, μια ανασκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων δεν υποδεικνύει αύξηση των διαμαρτιών σε παιδιά εκτεθειμένα σε δεσμοπρεσσίνη κατά τη διάρκεια της κύησης. Έως σήμερα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά επιδημιολογικά δεδομένα. Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν συνταγογραφείται σε εγκύους. Συνιστάται παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης λόγω του αυξημένου κινδύνου προεκλαμψίας (παράγραφοι 4.3 και 4.4). Ο ιατρός πρέπει να σταθμίζει τα πιθανά θεραπευτικά οφέλη έναντι του πιθανού κινδύνου σε κάθε περίπτωση.

Γαλουχία: Αποτελέσματα από αναλύσεις γάλακτος γαλουχουσών μητέρων που λάμβαναν υψηλή δόση δεσμοπρεσσίνης (300 μικρογραμμάρια ενδορρινικά) υποδεικνύουν ότι οι ποσότητες δεσμοπρεσσίνης που ενδέχεται να μεταφερθούν στο βρέφος είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις ποσότητες που απαιτούνται, για να επηρεαστεί η διούρηση. Πρέπει να ληφθεί μια απόφαση όσον αφορά τη διακοπή της γαλουχίας ή τη διακοπή/αποχή της θεραπείας με πόσιμο διάλυμα Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα.

Γονιμότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τη γονιμότητα.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το πόσιμο διάλυμα Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml δεν έχει ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Θεραπεία χωρίς ταυτόχρονο περιορισμό της πρόσληψης υγρών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κατακράτηση υγρών/υπονατριαιμία με ή χωρίς ταυτόχρονα προειδοποιητικά σημεία ή συμπτώματα. Τα σχετικά συμπτώματα περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, ναυτία/έμετο, μειωμένο νάτριο ορού, αύξηση του σωματικού βάρους και, σε σοβαρές περιπτώσεις, σπασμούς, κώμα (βλ. παράγραφο 4.4). Η συχνότητα των ανεπιθύμητων συμβάντων που αναφέρονται παρακάτω ορίζεται με βάση την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000, < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000) και μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Οι πιο συχνές περιλαμβάνουν κεφαλαλγία και διαταραχές του γαστρεντερικού.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Πολύ σπάνιες: υπονατριαιμία.
Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ σπάνιες: συναισθηματικές ενοχλήσεις.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: κεφαλαλγία.
Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: κοιλιακό άλγος και ναυτία.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Πολύ σπάνιες: αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr

4.9 Υπερδοσολογία Υπερδοσολογία του πόσιμου διαλύματος Nictur 360 μικρογραμμάρια/ml οδηγεί σε παρατεταμένη διάρκεια δράσης με αυξημένο κίνδυνο κατακράτησης νερού και υπονατριαιμίας.

Αντιμετώπιση: Παρόλο που η θεραπεία της υπονατριαιμίας πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε ασθενή, μπορούν να ακολουθηθούν οι ακόλουθες γενικές συστάσεις: η υπονατριαιμία αντιμετωπίζεται με διακοπή της θεραπείας με δεσμοπρεσσίνη, περιορισμό των υγρών και συμπτωματική θεραπεία, εάν χρειάζεται.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GP-Pharm, S.A Polígono Industrial Els Vinyets – Els Fogars, sector 2, Carretera Comarcal C244, Km 22, 08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona), ΙΣΠΑΝΙΑ. Τηλέφωνο: +34 93 8182200, Φαξ: +34 93 8182210

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 10276

Για την πλήρη Π.Χ.Π. πριν τη συνταγογράφηση αποταθείτε στην εταιρεία

Cranfix®

Cranberry (36 mg PAC)

με **εκχύλισμα cranberry Β. Αμερικής**
πλούσιο σε **PACs** (προανθοκυανιδίνες)

- ✓ Προανθοκυανιδίνες κράνας
- ✓ Βιταμίνη C
- ✓ Ψευδάργυρος
- ✓ Σελήνιο

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΖΑΧΑΡΗ & ΑΛΑΤΙ

60 μαλακές κάψουλες

by Uni-pharma
Cranfix®
Cranberry
(36 mg PAC)
60 μαλακές κάψουλες
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ & ΑΛΑΤΙ

Εγγυημένη & **υψηλή**
απόδοση ανά κάψουλα σε
προανθοκυανιδίνες (PACs)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης • Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας • Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά • Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 91107/21-12-2012 *(ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ)*

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

50 χρόνια

Επενδύουμε στην Ελλάδα,
Παράγουμε στην Ελλάδα,
Στηρίζουμε την Ελλάδα.

Duagen
dutasteride

ZARMOL
bicalutamide

Zidrolin
tamsulosin HCl

CECURE
solifenacin succinate

UFEXIL
ciprofloxacin

DEMOcran
Συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα
cranberry & προβιοτικά

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 79299/15-9-2017

UROL/056/1 Ιούνιος 2018

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

www.demo.gr | Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια |

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aurum
with **Manuka Honey**

Οι σάκοι στομίας AURUM διαθέτουν νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των οστομικών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ο εμπλουτισμός του κολλητικού με ιατρικού βαθμού μέλι Manuka με επουλωτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες

Μέλι Manuka

Συμβάλει στην βελτίωση της υγείας του δέρματος γύρω από το στόμιο

Η Γενική Χημικών Προϊόντων διαθέτει δίκτυο επισκεπτών που καλύπτει κάθε σημείο της Ελλάδας, ώστε να έχετε άμεση εξυπηρέτηση όποτε και όπου την χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα για τα υλικά μας: www.gcp.gr
Αθήνα: Αυγής 60 Κηφισιά, ΤΚ 145 64, τηλ: 210 6203000, ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ: 8005005150
Θεσσαλονίκη: Πέτρου Συνδίκα 18, ΤΚ 546 45, τηλ: 2310 868174
Πάτρα: Καλομοίρη 79, ΤΚ 264 43 τηλ: 2610 431 974

Welland

gcp med ΓενικηΧημικων

Coloplast
60
years of care
Forward
together

Μαζί, προχωράμε μπροστά

Εδώ και 60 χρόνια, βελτιώνουμε τις ζωές των ατόμων με πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες. **Σε αυτό το ταξίδι, δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας ...**

Επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο μοιράζονται μαζί μας το όραμα τους, για μια καλύτερη φροντίδα των ασθενών τους. **Άτομα με πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες,** μας μεταφέρουν τις επιθυμίες τους και τις απόψεις τους.

Γιορτάζουμε μαζί σας **τη Δύναμη της Συνεργασίας. Αυτή που μας ενώνει. Αυτή που μας βελτιώνει και μας οδηγεί μπροστά!**

MAVROGENIS
Απ. Αντιπρόσωπος Coloplast A/S - Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση -www.coloplast.gr
Το Coloplast είναι σήμα κατατεθέν της Coloplast A/S. © 2018-05